

INDICADO POR: Dra Priscila
☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS

ELIETE FERREIRA DE SOUZA

IDADE: 60 PESO: 64 ALTURA: 1,56 PROFISSÃO: Empregada.
SINTOMAS: sonolência diurna, Acorda cansada, sente sufocada em 80.

QUEIXAS: Ronco;

MEDICAMENTOS:

MÉDICO: Dra Priscila

MARCAPASSO: () S () N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N

EXERCÍCIO FÍSICO:

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: 00h 01h HORA QUE ACORDA: 08h 08h30'

COCHILHO () S () N DORME ACOMPANHADO: () S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: (X) S () N / DORMEM NO QUARTO: () S (X) N PET NO QUARTO: () S () N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA () N

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: há ~ 35 anos.

TIPO DE RESPIRAÇÃO: BANHEIRO/NOITE: 1x 2x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: MALLAMPATI: IAH: 19,3elh SPO2: 82% IDO: 111h

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: IDO no PEM: 45,21h.

Fez cirurgia plástica Nariz - canal D mais estreito.

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA

() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

07/05/2026 - Avaliação.

SONOFISIO

RUA SANTA ELZA, 418, VILA ADYANA
TEL - 3921-1001 / 99724-7053



Rua Professor Alfredo Vieira de Moura, 85
Vila Adyana - São José dos Campos - SP
Email - contato@silveirasjc.med.br
Tel: (12) 39226109 / 39179828 / 988666109

Paciente: Eliete Ferreira De Souza

SOLICITAÇÃO DE CPAP

Paciente com roncacos e apnéia Grave - IAH: 19/H, IAH SONO REM 45

Solicito adaptação para CPAP, com rampa, automático, umidificador e seguimento de adaptação.

Grata,

Dr. Priscila Leite da Silveira
Otorrinolaringologista
CRM 140497

Priscila Leite da Silveira
CRM 140497 SP

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA BASAL

Nome: ELIETE FERREIRA DE SOUZA

Data do Exame: 18-02-2026

Peso: 64 kg

Médico Solicitante: DRA. PRISCILA LEITE DA SILVEIRA

Sexo: Feminino

Idade: 60 anos

Altura: 1,56 m

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 18/02/2026 21:56 e finalizado às 19/02/2026 05:45.

A latência para início do sono foi de **38,5 min** e a latência para o sono REM de **102,0 min**.

O tempo total de sono (TTS) foi de 361,0 min, com eficiência do sono de **77,0 %**.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **4,2 %** de estágio N1, **53,9 %** de estágio N2, **21,7 %** de estágio N3 e **20,2 %** de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 69,5 min. Ocorreram 63 despertares, sendo o índice de **8,1 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **0,0 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 116, sendo 2 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 114 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **19,3 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 46,0 e o IDR durante o sono NREM foi de 12,5. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 19,3 (nº/h), sendo 0,3 apneia/h e 18,9 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 94%, a média de 94% e a mínima de 82%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 11,6 (nº/h), sendo que em REM foi de 45,2 (nº/h) e em NREM foi de 7,5 (nº/h). Permaneceu 3,5 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (14), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório (**19,3 nº/h**) (VN= até 5 nº/h);
2. Saturação mínima da oxi-hemoglobina (**82%**);
3. Latência para o início do sono (**38,5 min**) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM (**102,0 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono (**77,0 %**) (VN= ≥ 85%);
6. Índice de despertares **8,1 nº/h** (VN= até 15 nº/h);
7. Percentual do estágio N1 (**4,2 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 (**53,9 %**) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta (**21,7 %**) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM (**20,2 %**) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco leve constante verificado via sensor de ronco;
12. Presença de alteração do ritmo cardíaco.

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

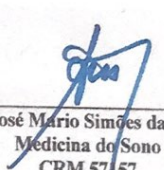
Exame evidenciando índice de distúrbio respiratório de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mário Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: ELIETE FERREIRA DE SOUZA

Data do Exame: 18-02-2026

DADOS DO PACIENTE:

Nome: ELIETE FERREIRA DE SOUZA
ID: 0
Altura: 1,56 m
Peso: 64 kg
Sexo: Feminino
Data de Nascimento: 11-1-1966
IMC: 26,30

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame: 21:56:34
Data do Exame: 18-02-2026
Médico Solicitante: DRA. PRISCILA LEITE DA SILVEIRA

Análise do Sono	
Data/Horário de Início:	18/02/2026 21:56
Data/Horário de Término:	19/02/2026 05:45
Tempo Total de Registro (TTR):	469,0
Tempo Total de Sono (TTS):	361,0
Latência para o início do sono:	38,5
Latência para o sono REM:	102,0
Tempo acordado após o adormecer:	69,5
Eficiência do Sono (TTS/TTR x 100):	77,0 %

Estágios do Sono					
	N1	N2	N3	REM	Vigília
Minutos	15,0	194,5	78,5	73,0	108,0
% de TTS	4,2	53,9	21,7	20,2	23,0

Despertares			
	Número		Índice (nº/h)
Total despertares	de	63	8,1

Frequência Cardíaca		
	Média [bpm]	Máx [bpm]
REM	62,4	82
NREM	56,4	75
Vigília	63,7	84

Valor de referência para o teste de apnéia e hipopnéia

Apneias/Hipopneias/RERAs								
	Apneias			Apneias (A)	Hipopneias (H)	A + H	"RERA"	A + H + "RERA"
	Central	Obstrutiva	Mista					
Número	0	2	0	2	114	116	0	116
Índice	0,0	0,3	0,0	0,3	18,9	19,3	0,0	19,3
Índice em REM	0,0	0,8	0,0	0,8	45,2	46,0	0,0	46,0
Índice em NREM	0,0	0,2	0,0	0,2	12,3	12,5	0,0	12,5
Duração máx (seg)	0	17,2	0	17,2	30,2	30,2	0	30,2
Duração média (seg)	0	16,2	0	16,2	15,9	16,0	0	16,0
Índice em Supino	0	0	0	0	0	0	0	0
Índice em Não Supino	0,0	0,3	0,0	0,3	18,9	19,3	0,0	19,3

- Apneia = queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, com duração ≥ 10 segundos;
- Hipopneia = queda de 30% do fluxo medido pela cânula de pressão associada à dessaturação de 3% e/ou associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos;
- RERA (Respiratory effort related arousals) = achatamento da curva de fluxo aéreo indicado pela cânula de pressão associada a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos.

Índice de apneia + hipopneia: 19,3 (nº/h)

Índice de distúrbio respiratório (IDR = Apneia + Hipopneia + "RERA"): 19,3 (nº/h)

DADOS DA OXIMETRIA		
	Média de SAO2	Menor SAO2
Sono:	94%	82%
NREM:	94%	86%
REM:	93%	82%
Vigília:	94%	84%

Valor de oximetria predominante durante o sono: 95%

Total de dessaturações: 91

"PLMS" (Periodic limb movements in sleep) Movimentos periódicos de membros inferiores durante o sono		
EMG tibial bilateral	Número	Índice (nº/h)
"PLMS"	0	0,0
"PLMS" associados a despertares	0	/

POSIÇÃO DE OCORRÊNCIAS DAS APNEIAS:

	REM				
	AC	AO	AM	Hipo	RERA
PRONE	0	1	0	16	0
DIREITO	0	0	0	21	0
ESQUERDO	0	0	0	18	0
SUPINO	0	0	0	0	0
	NREM				
	AC	AO	AM	Hipo	RERA
PRONE	0	1	0	33	0
DIREITO	0	0	0	18	0
ESQUERDO	0	0	0	8	0
SUPINO	0	0	0	0	0

Nome: ELIETE FERREIRA DE SOUZA

Data do Exame: 18-02-2026

pág. 4